

背景信息：

- 中轴型脊柱关节炎（axSpA）是一种累及脊柱和骶髂关节的免疫介导炎症性疾病，分为放射学阳性中轴型脊柱关节炎（强直性脊柱炎，AS）和放射学阴性中轴型脊柱关节炎（nr-axSpA）。该病好发于中青年男性患者，患者常年饱受背痛和“躯体僵硬”折磨，若不及时控制，可能导致脊柱变形及关节损伤。与此同时，夜间疼痛和晨僵会增加患者的心理负担，严重影响患者的生活质量。
- 作为中国首个且唯一覆盖中轴型脊柱关节炎全疾病谱的口服靶向药物，**乌帕替尼**凭借对 JAK1 高选择的作用机制，能够显著改善患者疾病活动度，为广大患者带来治疗新选择。除了通过适当药物治疗控制病情进展外，维持良好的身体姿态、针对性的康复运动对提高患者的脊柱活动度和灵活度也至关重要，不仅可以减轻患者的疾病负担、改善生活质量，更能在一定程度上增强患者的治疗信心。
- 5 月 21 日是世界脊柱健康日，为了进一步提升公众对该疾病的认知与关注，客户**艾伯维**拟对**风湿免疫科权威专家**进行采访，并发布一篇疾病科普新闻稿件，以传递以上疾病和治疗等关键信息。

内容要求：

- 请基于以上背景，撰写一篇医疗科普稿件（字数控制在 1000-1500 字左右），稿件预计发布在大众健康类媒体上，其中需要拟写风湿免疫科专家的引言（专家名字和 title 可用“XX”代替），行文结构和逻辑要条理清晰。

参考资料：

[瑞福®（乌帕替尼缓释片）纳入医保，填补中轴型脊柱关节炎治疗空白](#)
[这种脊柱关节炎好发于中青年男性，北医三院专家谈如何诊治康复](#)

乌帕替尼纳入医保，为应对“脊柱危机”带来新希望

脊柱，我们中国人口中的“脊梁骨”，是我们人体的支柱，也是我们人体的第二生命线。然而，有这么一群人——中轴型脊柱关节炎（axSpA）患者，他们的“脊梁骨”正在遭受病痛的折磨。在 5 月 21 日世界脊柱健康日到来之际，让我们关注中轴型脊柱关节炎（axSpA）及其患者，关注中轴型脊柱关节炎的治疗措施。为此，我们特意邀请了上海市 xx 医院风湿免疫科 A 主任，为我们带来详细介绍。

不死的癌症——中青年男性患者饱受折磨

中轴型脊柱关节炎（axSpA），正悄悄侵袭着许多青壮年男性的脊柱。它像一位顽固的“破坏者”，主要攻击脊柱和骶髂关节，带来难以忍受的疼痛和身体“僵硬感”。在疾病早期，即便 X 光片上看不出明显破坏（即“放射学阴性”阶段），疼痛与僵硬也可能早已存在。若不及早干预，部分患者可能发展为脊柱融合、变形，因此，民间又有人称它为“不死的癌症”。更折磨的是，夜深人静时的疼痛和清晨起身时的僵硬，不仅消耗着身体，也在不断加重患者的心理负担，严重拉低了生活质量。

A 主任说：“中轴型脊柱关节炎（axSpA）是一种慢性炎症性风湿病，分为放射学阳性中轴型脊柱关节炎（强直性脊柱炎，AS）和放射学阴性中轴型脊柱关节炎（nr-axSpA），病因不明，好发于青壮年男性。由于公众认知度低，且其症状，如：腰背痛、臀区疼痛，甚至虹膜炎、腹泻等缺乏特异性，所以存在误诊率高的问题，极易被误诊为腰肌劳损等常见病。患者常因不同症状分散于各科室就诊，而医生认知也存在差异，导致从发病到确诊可能长达七八年，多数患者在青少年时期即出现的病情被严重延误。”

对症下药——日常护理加乌帕替尼利好中轴型脊柱关节炎患者

乌帕替尼作为中国首个且唯一覆盖中轴型脊柱关节炎全疾病谱的口服靶向药物，能够显著改善患者疾病活动度，为广大患者带来治疗新选择。多项国际多中心临床研究证实，新型小分子口服药乌帕替尼能快速、全面改善强直性脊柱炎及放射学阴性中轴型脊柱关节炎（nr-axSpA）患者的临床症

状与关键指标，包括疼痛、炎症水平、身体功能及疾病活动度。其口服给药的便利性与快速起效的特性，能有效帮助患者尽早回归正常的工作与生活。

此外，A 主任呼吁患者朋友们：“药物治疗确实是控制病情的关键，但千万别忽视了日常护理。平时要注意保持良好的坐姿、站姿，避免脊柱受压变形；还可以试试脊柱伸展操、游泳这类针对性康复运动，它们能帮你提高脊柱活动度和灵活度。坚持做好这些，不仅能减轻疼痛、改善生活质量，更能让患者们在治疗中更有信心，我们医生会和患者们一起努力，对抗疾病！”

中轴型脊柱关节炎患者新福音——乌帕替尼进医保

科学家和医生们在医学领域与中轴型脊柱关节炎抗争的同时，国家的医保政策也传来好消息。

2025 年 11 月 28 日，新版本国家医保目录正式公布：乌帕替尼作为今年医保目录新纳入的唯一覆盖中轴型脊柱关节炎的靶向药，正式纳入国家医保，填补了这一领域的空缺。这一政策将大大减轻中轴型脊柱关节炎患者及其家庭的经济负担。

【Test 2】专家沟通手册及社媒发布文案

背景信息：

- 骨质疏松症是中老年群体最常见骨骼疾病之一。随着我国人口老龄化程度加剧，骨质疏松症患者人数逐年上升。其中 65 岁以上的女性患病率超过 50%¹；50 岁以上男性中，有 1/5 会发生骨质疏松性骨折²。然而，我国骨质疏松性骨折的诊疗现状还存在诊断率低、治疗率低、治疗依从性差和不规范的问题，亟待行业合力推动解决。（我国目前的国情）
- 基于以上背景，由安进中国支持、国家卫生健康委科学技术研究所和中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会联合主办的“骨力计划”，在[中国健康传播激励计划平台发布](#)，力求探索建立一套符合我国国情的脆性骨折高风险患者标准化管理模式，以助力骨质疏松症的诊治和脆性骨折的预防。
- 近期，围绕当前骨松管理现状及行业发展趋势，媒体将联动多家 FLS 认证医院，打造**骨健康深度医患故事视频**，采访骨质疏松症患者和专家，**挖掘医患互动中的动人故事**，展现医疗机构、协会、企业等多方合力的努力成果，引发大众情感共鸣的同时，强化骨松患者进行疾病长期管理的意识。

内容要求：

- 请基于以上项目背景，为参与本项目的专家拟写沟通手册，具体要求如下：
 - 需向专家阐明项目发起背景、采访目的和拍摄安排（具体时间可以先用“XX”代替）；
 - 主体内容需为专家拟定 3-4 个媒体可能的提问方向和参考回答要点；——针对本活动相关的，侧重于科普还是更侧重于安进产品的宣传？
 - 问题之间需层层递进，参考回答以 bullet points 形式呈现要点即可；
- 假设该视频将于明年在“央视网”视频号和抖音发布，请推荐合适的发布时间节点，并拟写发布文案：
 - 推荐发布的时间节点需要阐明理由；
 - 社媒文案需要符合媒体和发布平台风格，并与疾病类型和负担相结合，可添加 1-2 个 hashtag；

参考资料：

[安进支持多学术机构启动“骨力计划”，探索脆性骨折患者标准化管理模式](#)

[安进普罗力®获批新增适应症](#)

[安进普罗力®获批新适应症，用于治疗骨折高风险的糖皮质激素诱导的骨质疏松症](#)

¹ 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会.原发性骨质疏松症诊疗指南（2022）.中华骨质疏松与骨矿盐杂志. 2022,15(6): P573-P611.

² 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会.男性骨质疏松症诊疗指南.中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志. 2020,13(5):381-395. doi: 10.3969/j.issn.1674-2591.2020.05.001.

“骨力计划”项目专家沟通手册

一、项目核心信息说明

（一）项目发起背景

随着我国老龄化加剧，骨质疏松症患者人数也在不断攀升。且骨质疏松存在发病率高的特点：50 岁以上的女性，患病率为 32.1%，但是病患知晓率仅为 7.0%；65 岁以上女性患病率超 50%；50 岁以上男性中 1/5 会发生骨质疏松性骨折。此外，目前该病存在诊断率低、治疗率低、治疗依从性差及诊疗不规范等问题，骨质疏松症的诊疗涉及医院多个科室，所以为患者就诊，随访等综合管理带来了巨大挑战。

为此，由安进中国支持，国家卫生健康委科学技术研究所和中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会联合主办“骨力计划”，旨在建立符合我国国情的脆性骨折高风险患者标准化管理模式，助力骨质疏松症诊治与脆性骨折预防。

（二）采访目的

- 1.向大众科普骨质疏松症危害、诊疗现状及长期管理重要性，提升公众对该疾病的认知。
- 2.展现“骨力计划”的价值与意义，以及医疗机构、协会、企业等多方合力推动骨松管理的成果。
- 3.通过专家视角，强化骨松患者长期管理意识，增强患者治疗的信心。

（三）拍摄安排

- 1.拍摄时间：暂定为 XX 年 XX 月 XX 日（具体时间将根据专家日程提前沟通确认）。
- 2.拍摄地点：上海市 XX 医院指定拍摄区域（将提前做好场地预约，布置与设备调试）。
- 3.拍摄时长：单专家采访预计 30-40 分钟，整体拍摄流程将高效衔接，尽量减少对专家工作与正常休息的影响。

4.前期对接：拍摄前 3 个工作日，工作人员将与专家确认采访细节，同步采访提纲初稿，便于专家提前准备。

二、媒体可能的提问方向及参考回答要点

提问方向 1：

当前我国骨质疏松症及脆性骨折管理面临哪些主要挑战？这些挑战对患者和医疗体系分别有什么影响？

参考回答要点：

- 患者层面：大众对于骨质疏松症认知不足，早期无症状，所以易忽视，确诊后也存在治疗依从性差的问题，导致病情延误，增加脆性骨折风险，影响生活质量甚至危及生命。
- 医疗层面：部分基层医疗机构诊断技术不足，医生对疾病规范诊疗认知存在差异，导致诊断率低、治疗不规范，加重医疗资源负担。
- 社会层面：随着我国老龄化的加剧，患病人数也越来越多，现有的管理模式难以满足需求，需要标准化管理体系提升整体管理水平。

提问方向 2：

能否简单介绍一下“骨力计划”？该计划的发起的核心目标是什么？相较于以往的骨松管理举措，它在解决当前行业痛点上有哪些独特优势？

参考回答要点：

- 简单介绍：“骨力计划”主要分为三个模块：推动患者管理和数字化平台建设、增强骨骼领域学术交流、传播健康骨骼理念。我们将使用数字化工具，找适合中国的患者管理办法。再通过宣传科普、规范诊疗、长期随访和推广，建立长期有效的管理体系，提升脆性骨折高风险患者管理水平，实

现骨健康理念传播、行动落地、标准建立。我们致力于推动医疗模式从传统的“有病治病”向“预测与预防”转变。

- 核心目标：建立符合我国国情的脆性骨折高风险患者标准化管理模式，推动骨质疏松症规范诊治与脆性骨折有效预防。
- 独特优势：由国家卫生健康委科学技术研究所、中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会联合主办，权威机构背书，确保管理模式的科学性与规范性；联动多家 FLS 认证医院，整合优质医疗资源，便于模式落地推广；有企业支持，为项目提供资源保障，形成“医、协、企”多方合力，更易突破行业痛点。

提问方向 3:

在“骨力计划”推进过程中，您所在的医疗机构（或您个人）主要参与哪些工作？在与患者沟通、推动疾病长期管理方面，有哪些印象深刻的医患互动故事可以分享？

参考回答要点:

- 参与工作：参与脆性骨折高风险患者筛查标准制定、标准化管理流程优化；开展患者教育活动，普及骨松防治知识；培训基层医护人员，提升区域骨松诊疗水平。
- 医患故事方向（供专家结合实际补充）：某位老年患者因忽视骨松导致骨折，经规范管理后恢复良好，重拾生活信心；某患者起初治疗依从性差，通过医护人员耐心沟通与个性化管理方案，逐渐坚持长期治疗等，体现项目对患者的实际帮助。

提问方向 4:

对于广大骨质疏松症患者，您认为在疾病长期管理中需要重点关注哪些方面？同时，对公众预防骨质疏松症有什么建议？

参考回答要点：

- 患者长期管理重点：坚持规范治疗，听从医生的治疗方案，不要随意停药或调整方案；定期复查骨密度、血钙等指标，及时调整管理方案；注重饮食补钙与维生素 D 摄入，结合适当运动（如散步、太极拳），避免剧烈运动导致骨折；保持良好生活习惯，戒烟限酒，避免熬夜。
- 公众预防建议：从小注重骨骼健康，保证充足钙与维生素 D 摄入；不同年龄段坚持适当运动，增强骨密度；40 岁以上人群定期进行骨密度检测，尤其是女性绝经后、男性 50 岁以上等高风险人群，做到早发现、早干预。

“骨力计划”医患故事视频发布时间及社媒文案

一、推荐发布时间节点及理由

时间：重阳节（农历九月初九，明年公历约 10 月中下旬）

理由：重阳节有“敬老、爱老”的传统，与骨质疏松症主要高发人群（中老年群体）高度契合。此时发布视频，能借助节日对老年人健康的关注氛围，引发子女对父母骨骼健康的重视，强化“关爱长辈骨骼健康”的情感共鸣，提升视频传播度与社会关注度。

文案：

“岁岁重阳，今又重阳，关爱长辈健康，从守护‘脊梁’开始！我国 65 岁以上女性骨质疏松症患病率超 50%，长辈的骨骼健康藏着晚年生活质量的密码。‘骨力计划’联合多家医院，记录医患携手对抗骨质疏松症的动人故事；看医疗、协会、企业多方合力如何为长辈骨骼健康保驾护航。转发这份‘骨健康守护指南’，愿每位长辈都能拥有硬朗骨骼，安享幸福晚年。

#骨力计划 #重阳节关爱长辈骨健康”